QUESTÕES ANTIGAS DE REUMATOLOGIA

Caderno de questões · transcrição limpa

Foram mantidos os enunciados e alternativas existentes, incluindo repetições e cortes assinalados no documento. A ordem segue os conjuntos de imagens enumerados na transcrição. O gabarito foi elaborado de forma independente.

Imagem 01

1. A gota é um distúrbio metabólico que se manifesta por níveis elevados de ácido úrico sérico, crises recorrentes de artrite aguda e formações crônicas de cristais de monurato de sódio. Pode ser classificada como primária ou secundária (quando se relaciona a outras condições que concorrem para o acúmulo de ácido úrico sérico). O principal mecanismo da hiperuricemia em pacientes com gota primária é:

a. Dieta rica em purinas

b. Aumento da taxa de renovação celular

c. Diminuição da excreção renal de ácido úrico

d. Deficiência total da enzima hipoxantinaguanina fosforribosiltransferase (HGPRT-ase)

Imagem 02

4. Sobre as fraturas transtrocanterianas, marque a correta:

a) São fraturas com altos índices de pseudoartrose por acometerem região de osso osteoporótico

b) Podem ser tratadas com fixação dos fragmentos e nos pacientes com boa capacidade de deambular dá-se preferência para as artroplastias totais de quadril

c) São classificadas por Tronzo, sendo as fraturas tipo I e II mais estáveis

d) O tratamento deve sempre ser realizado de urgência pelo alto risco de necrose da cabeça do femur

Imagem 03

18. Paciente, 40 anos, sofreu queda da própria altura com trauma de cotovelo direito. Encaminhada dos PS há 14h, atendida imediatamente pelo traumatologista. Exame físico: pele íntegra, edema e deformidade ao nível do cotovelo, neurovascular normal. Radiografia mostra luxação póstero-lateral do cotovelo. A conduta correta é:

a) Redução fechada imediata na sala de gesso, imediatamente após diagnóstico

b) Encaminhamento para centro cirúrgico para redução aberta e reparação ligamentar, necessária de rotina

c) Redução incruenta sob anestesia

d) Colocação de tala gessada, internar o paciente e programar redução no centro cirúrgico na manhã do dia seguinte, em condições ideais

Imagem 04

6. Mulher, 32 anos, apresenta-se com queixa de fraqueza muscular proximal, de início há vinte dias e piora progressiva, acompanhada de heliotropo nas regiões palpebrais e sinal de Gottron nas MCFs e IFPs. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é:

a) LES

b) Vasculite urticária

c) Reação de hipersensibilidade

d) Dermatomiosite

Imagem 05

2. Criança obesa, 10 anos, claudicando, com dor no quadril e marcha com rotação externa do membro acometido. Das doenças abaixo, qual a mais provável?

a) Doença de Legg-Calvé-Perthes

b) Artrite reumatóide juvenil

c) Epifisiolise proximal do fêmur

d) Sinovite transitória do quadril

Imagem 06

16. Na paralisia cerebral do tipo hemiparesia espástica tipo III, o paciente apresenta:

a) Deformidade somente do pé

b) Deformidade do pé e joelho

c) Deformidade do pé, joelho e quadril

d) Deformidade do joelho e quadril

Imagem 07

12. As fraturas com maior facilidade para consolidação são aquelas que apresentam:

a) Traço cominutivo (?)

b) Traço espiral

c) Desvio em valgo

d) Desvio em varo

Imagem 07a

2. O LES é diagnosticado com base em critérios clínicos e laboratoriais. Sobre os auto-anticorpos associados à enfermidade, é verdadeiro:

a) O anti-Sm é também observado na artrite reumatóide

b) O anti-RNP é também observado na síndrome de Sjögren

c) O Anti-Ro e Anti-La são também observados na esclerodermia

d) O Anti-coagulante lúpico, quando positivo, pode indicar síndrome do anticorpo antifosfolípede secundária

Imagem 08

10. O fator reumatóide é um auto-anticorpo produzido contra a fração Fc da IgG e pode ser encontrado na seguinte condição clínica:

I – Síndrome de Sjögren

II – Hepatite C

III – Artrite Reumatóide Estão corretas as assertivas:

a) I e II.

b) II e III.

c) Somente III.

d) I, II e III.

Imagem 09

20. Em relação à epidemiologia do trauma raquimedular, podemos afirmar que:

a) A principal causa são os ferimentos por arma de fogo, consequentes à grande violência urbana que enfrentamos atualmente.

b) É muito mais comum o acometimento da região lombar, mais exposta a traumas no trânsito ou trauma diretos.

c) A principal causa são os acidentes de trânsito, responsáveis por mais de 50% dos casos.

d) É muito mais comum o acometimento da região torácica, mais exposta a traumas, sejam por arma de fogo ou acidente de trânsito.

Imagem 10

8. A densitometria óssea é exame considerado padrão ouro no diagnóstico da osteoporose. Tal procedimento deve ser realizado na seguinte circunstância:

a. Homens a partir dos 40 anos, independente de fatores de risco

b. Mulheres a partir dos 40 anos, independente de fatores de risco

c. Mulheres no primeiro ano após a menopausa

d. Mulheres com mais de 65 anos

Imagem 11

19. Qual a afirmação correta?

a) A fratura desviada consolida 2x mais rápido que a fratura não desviada

b) A consolidação radiológica da fratura precede a consolidação clínica

c) Toda fratura desviada é cirúrgica

d) Toda fratura intra-articular necessita redução anatômica

Imagem 12

7. A osteoporose é uma desordem caracterizada por diminuição da massa óssea e maior risco de fraturas. Das medicações abaixo, assinale aquela associada à um maior risco para tal enfermidade:

a. Hidroclorotiazida

b. Heparina

c. Loratadina

d. Carvedilol

Imagem 13

13. Paciente, 18 anos, vítima de acidente automobilístico. Atendido no PS. Foi feito o diagnóstico de fratura de diáfise de úmero, simples, fechada e com desvio segmentar em varo. [...] (INCOMPLETO)

a) Anterior

b) Medial

c) Lateral

d) Posterior

Imagem 14

3. A sacroilite é achado característico das espondiloartrites, cujo protótipo é a espondilite anquilosante. Tal achado pode ser detectado ao exame físico através da manobra de:

a) Tinel

b) Patrick-Fabere

c) Phalen

d) Thompson

Imagem 15

9. A velocidade de hemossedimentação (VHS) avalia a resposta inflamatória de fase aguda através da medida de

a) haptoglobina

b) amilóide A

c) fibrinogênio

d) albumina

Imagem 16

1. O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença reumática de etiologia desconhecida e natureza autoimune. A cerca do envolvimento renal na enfermidade, assinale a assertiva verdadeira:

a) Geralmente pacientes com nefrite lúpica em atividade apresentam anti-coagulante lúpico positivo

b) É raro o envolvimento renal no LES

c) A glomerulonefrite proliferativa difusa (classe IV) é a classe histológica mais frequentemente observada

d) A biópsia renal é contra-indicada em pacientes com proteinuria maciça pelo risco de sangramento

Imagem 17

4. As espondiloartrites são doenças que compartilham características clínicas, laboratoriais e genéticas. Sobre tais enfermidades, é verdadeiro:

a) É comum o achado de entesopatia do calcâneo

b) Poliartrite crônica de pequenas articulações é a apresentação mais comum da espondilite anquilosante

c) A coriorretinite é a manifestação oftalmológica mais comum no grupo

d) A artrite psoriásica geralmente antecede o diagnóstico de psoríase cutânea

Imagem 18

5. As espondiloartrites abrangem um grupo de doenças que apresentam peculiaridades epidemiológicas, clínicas, radiográficas e imunogenéticas. Sobre as características desse grupo é correto afirmar que:

a. Apresentam acometimento da coluna vertebral em especial do segmento cervical, com subluxação atlas- áxis

b. A agregação familiar é marcante, sendo o fator maior de risco a positividade para o Anti CCP

c. O acometimento ocular é importante, caracterizado como iridociclite, unilateral, recidivante

d. O envolvimento articular periférico caracteriza-se por comprometimento assimétrico de grandes articulações de membros superiores.

Imagem 19

17. Na classificação de Herring para doença de Perthes, o tipo:

a) A é caracterizado por 50% de achatamento do pilar lateral

b) B é caracterizado por 70% de achatamento do pilar lateral

c) B é caracterizado por 60% de achatamento do pilar lateral

d) C é caracterizado por achatamento acima de 50% do pilar lateral

Imagem 20

4. Os anti-inflamatórios são um grupo de fármacos que tem em comum o objetivo de controlar a inflamação e promover analgesia. Podem ser classificados em anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e esteroidais (corticoesteroides). Sobre essas medicações marque a alternativa correta:

a. A nimesulida e o meloxican são considerados AINE não seletivos

b. Os AINEs seletivos cox 2 não necessitam de monitorização de função renal.

c. Os corticoesteróides quando usados a longo prazo, porém em doses baixas, não requerem avaliação da massa óssea.

d. O uso crônico de corticoesteróides por via inalatória ou tópica pode acarretar em eventos adversos semelhantes ao da terapia oral.

Imagem 21

5. Marque a correta:

a) A classificação de Gustillo para fraturas expostas é baseada na avaliação do tamanho do ferimento (até 1, de 1 a 10 e maior de 10 cm)

b) Paciente caiu do cavalo no curral com fratura da perna com ferimento de cerca de 4cm ao nível da fratura, sem pulso na topografia da a. tibial posterior. O seu diagnóstico é: fratura exposta da perna grau II de Gustillo

c) A complicação mais temida na fratura exposta é a infecção e por isso é muito importante a limpeza e o debridamento desses ferimentos

d) O tratamento da fratura exposta pode ser conservador, principalmente nos casos com mais de 6h de exposição

Imagem 22

3. Serafina, 30 anos, iniciou há 3 meses quadro de astenia, artralgia com edema articular associado em punhos, metacarpofalangeanas e joelhos. Concomitante apresentou erupção maculopapular na região malar e no dorso do nariz persistente, exacerbada com exposição solar e urina espumosa. Hemograma: Hb: 11,0 g/dl (VR: 12-16 g/dl), Leucócitos: 3000/mm3 (VR: 4000- 11000/mm3), Plaquetas: 80.000/mm3 (150.000-400.000/mm3). Considerando sua principal hipótese diagnóstica, o padrão do FAN esperado é:

a. Nuclear pontilhado fino

b. Nuclear homogêneo

c. Nuclear pontilhado fino denso

d. Nuclear pontilhado centromérico

Imagem 23

8. Mulher, 68 anos, IMC = 23, procura assistência médica com história de dor em joelhos, de início há dois anos. Relata piora com as atividades laborais e melhora com o repouso. Ao exame físico, observa-se aumento de volume dos joelhos, crepitação bilateral e dor aos movimentos. Baseando-se na principal hipótese diagnóstica, a conduta neste caso deverá incluir a seguinte orientação:

a) Uso de bengala, para amortecer o peso sobre os joelhos.

b) Artroplastia bilateral, imediatamente.

c) Controle do peso, pois a obesidade apresentada pela paciente é um fator que pior sua doença articular.

d) Prescrição de prednisona, 20 mg/dia, VO, durante 30 dias, devido ao quadro inflamatório.

Imagem 24

10. Em relação às fraturas expostas é correto afirmar: (INCOMPLETO)

a) A fratura exposta mais comum é a de [...]

b) [...] há exposição [..] para o meio externo

c) Está indicado uso de [...] em fraturas tipo II de Gustillo (?) e Anderson

d) Debridamento (?) e [...] têm se mostrado seguro na maioria dos [...]

Imagem 25

9. Nas fraturas de extremidades (?), podemos afirmar que: (INCOMPLETO)

a) [...] década de 60, graças às [...]

b) [...] maior incidência em [...] idosos

c) O aumento do 2IdC (?) não é fator de risco

d) A fratura intraarticular (?) é a mais comum

Imagem 26

14. Na investigação diagnóstica de um paciente com suspeita de fratura dos ossos da perna [...] pedir radiografias nas seguintes incidências: (INCOMPLETO)

a) AP, perfil, oblíqua D, oblíqua E

b) AP, perfil e axial do tornozelo

c) AP e perfil

d) AP, perfil e axial da patela

Imagem 27

5. A osteoporose é uma doença osteometabólica caracterizada por redução na densidade mineral óssea e aumento no risco de fraturas. Em seu tratamento, a atividade física deve ser encorajada. Assinale a atividade mais indicada para ganho de massa óssea e prevenção de fraturas:

a) Hidroginástica

b) Natação

c) Alongamento

d) Musculação

Imagem 28

6. Quais as áreas mais sujeitas às ulcerações de pressão?

a) Tuberosidade isquiática, trocanter, região sacra

b) Calcanhar, joelhos, trocanter

c) Trocanter, calcanhar, nuca

d) Cotovelo, região zigomática, ombro

Imagem 29

11. Em relação às fraturas (?) de diáfise da tíbia é correto afirmar que: (INCOMPLETO)

a) A fratura é mais comum no sexo feminino

b) Não é indicado tratamento conservador por ser um osso que [...]

c) A fixação com placa e parafuso é uma das formas (?) de tratamento cirúrgico

d) Não há associação com lesões de estrutura do joelho (ligamentos [...]) anterior e posterior (?)

Imagem 30

15. A paralisia cerebral (?) é uma patologia:

a) Evolutiva, causando por lesão nos núcleos da base

b) Não evolutiva, causada por lesão no cérebro imaturo

c) Lentamente progressiva, causada por lesão piramidal

d) Caracterizada por déficit cognitivo em 85% dos casos

Imagem 31

3. Sobre as fraturas do colo do fêmur, marque a incorreta:

a) Via de regra, nos pacientes mais jovens normalmente se preconiza a fixação da fratura e nos mais idosos se utiliza mais as artroplastias

b) Apresentam complicações como pseudoartrose e necrose avascular da cabeça que são menos comuns nas fraturas transtrocanterianas

c) São classificadas por Garden em quatro tipos, sendo as de grau I e II estáveis e as de grau III e IV instáveis

d) As estáveis são de tratamento conservador, com bons índices de consolidação

Imagem 32

2. Joana, 35 anos, gestante, costureira, com sensação de formigamento e queimação em mãos, principalmente no período noturno. Procurou o reumatologista apresentando, ao exame físico, sinais de Tinel e Phalen positivos, bilateralmente. Considerando a distribuição do nervo acometido, esta paciente apresenta parestesia, especificamente, em:

a. Primeiro, segundo, terceiro e parte do quarto dedo

b. Segundo, terceiro e quarto dedos

c. Todos os dedos das mãos exceto polegar

d. Todos os dedos das mãos

Imagem 33 · questão 1

1. A gota é um distúrbio metabólico que se manifesta por níveis elevados de ácido úrico sérico, crises recorrentes de artrite aguda e formações crônicas de cristais de monurato de sódio. Pode ser classificada como primária ou secundária (quando se relaciona a outras condições que concorrem para o acúmulo de ácido úrico sérico). O principal mecanismo da hiperuricemia em pacientes com gota primária é:

a. Dieta rica em purinas

b. Aumento da taxa de renovação celular

c. Diminuição da excreção renal de ácido úrico

d. Deficiência total da enzima hipoxantinaguanina fosforribosiltransferase (HGPRT-ase)

Imagem 33 · questão 2

2. Joana, 35 anos, gestante, costureira, com sensação de formigamento e queimação em mãos, principalmente no período noturno. Procurou o reumatologista apresentando, ao exame físico, sinais de Tinel e Phalen positivos, bilateralmente. Considerando a distribuição do nervo acometido, esta paciente apresenta parestesia, especificamente, em:

a. Primeiro, segundo, terceiro e parte do quarto dedo

b. Segundo, terceiro e quarto dedos

c. Todos os dedos das mãos exceto polegar

d. Todos os dedos das mãos

Imagem 33 · questão 3

3. Serafina, 30 anos, iniciou há 3 meses quadro de astenia, artralgia com edema articular associado em punhos, metacarpofalangeanas e joelhos. Concomitante apresentou erupção maculopapular na região malar e no dorso do nariz persistente, exacerbada com exposição solar e urina espumosa. Hemograma: Hb: 11,0 g/dl (VR: 12-16 g/dl), Leucócitos: 3000/mm3 (VR: 4000-11000/mm3), Plaquetas: 80.000/mm3 (150.000-400.000/mm3). Considerando sua principal hipótese diagnóstica, o padrão do FAN esperado é:

a. Nuclear pontilhado fino

b. Nuclear homogêneo

c. Nuclear pontilhado fino denso

d. Nuclear pontilhado centromérico

Imagem 33 · questão 4

4. Os anti-inflamatórios são um grupo de fármacos que tem em comum o objetivo de controlar a inflamação e promover analgesia. Podem ser classificados em anti- (INCOMPLETO)

GABARITO COMENTADO

Gabarito resumido e análise alternativa por alternativa

Nota metodológica: a marcação tradicional de prova não foi tomada como verdade. Questões incompletas, afirmações imprecisas e alternativas sobrepostas foram identificadas expressamente. As respostas servem para estudo e não substituem avaliação clínica.

01 — C	02 — C	03 — C*
04 — D	05 — C	06 — B
07 — B*	07a — D*	08 — D
09 — C*	10 — D	11 — D*
12 — B	13 — SEM RESPOSTA SEGURA	14 — B*
15 — C	16 — C*	17 — A
18 — C	19 — D*	20 — D*
21 — C	22 — SEM RESPOSTA ÚNICA	23 — A
24 — SEM RESPOSTA SEGURA	25 — SEM RESPOSTA SEGURA	26 — C*
27 — D	28 — A	29 — C*
30 — B	31 — D	32 — A
33.1 — C	33.2 — A	33.3 — SEM RESPOSTA ÚNICA
33.4 — SEM RESPOSTA SEGURA	—	—

Legenda: “sem resposta segura” indica insuficiência do enunciado, alternativas incompletas ou resposta não única; respostas qualificadas por ressalva não devem ser lidas como certeza absoluta.

Imagem 01 — Resposta: C

A menor eliminação renal de urato é o mecanismo predominante na hiperuricemia da gota primária.

A) A dieta pode contribuir, mas não é o principal mecanismo isolado.

B) O aumento de renovação celular explica causas de hiperprodução, como algumas neoplasias; não é a explicação predominante da gota primária.

C) Correta: a subexcreção renal de urato predomina, com fatores genéticos e renais.

D) A deficiência completa de HGPRT causa síndrome de Lesch-Nyhan, forma rara de hiperprodução; não corresponde à maioria dos casos.

Referências: [1]

Imagem 02 — Resposta: C

As fraturas transtrocanterianas são extracapsulares e tipicamente tratadas por osteossíntese; Tronzo I e II são padrões considerados estáveis.

A) Incorreta: possuem vascularização metafisária relativamente favorável e pseudoartrose é menos comum que nas fraturas intracapsulares do colo.

B) Incorreta como regra: a artroplastia total não é preferida rotineiramente em paciente deambulador apenas por essa característica; a fixação é usual.

C) Correta: a classificação de Tronzo descreve tipos I e II usualmente estáveis.

D) Incorreta: não há alto risco típico de necrose avascular da cabeça como nas fraturas intracapsulares; a cirurgia é precoce por outros motivos.

Referências: [5]

Imagem 03 — Resposta: C (A também pode ser aceitável)

Luxação simples posterolateral do cotovelo requer redução fechada precoce, habitualmente com analgesia e sedação, seguida de avaliação de estabilidade.

A) Possivelmente correta se a redução imediata for realizada com sedação/analgesia apropriadas e avaliação neurovascular; o local físico não é decisivo.

B) Incorreta: redução aberta e reparo ligamentar não são necessários de rotina em luxações simples redutíveis e estáveis.

C) Melhor formulação: redução incruenta sob analgesia/anestesia ou sedação, sem demora injustificada.

D) Incorreta: postergar a redução até o dia seguinte aumenta riscos sem justificativa apresentada.

Referências: [10]

Imagem 04 — Resposta: D

Fraqueza proximal, heliotropo palpebral e pápulas/sinal de Gottron caracterizam dermatomiosite.

A) O LES pode causar sintomas musculoesqueléticos e lesões cutâneas, mas heliotropo e Gottron apontam especificamente para dermatomiosite.

B) Vasculite urticariforme costuma apresentar lesões urticariformes prolongadas, não esse conjunto típico de sinais.

C) Hipersensibilidade não explica adequadamente o padrão cutâneo-muscular característico.

D) Correta: apresentação clássica de dermatomiosite.

Referências: [13]

Imagem 05 — Resposta: C

Obesidade, faixa etária e marcha em rotação externa sugerem epifisiólise proximal do fêmur (SCFE).

A) Perthes ocorre mais frequentemente em crianças menores e não apresenta associação tão típica com obesidade e rotação externa.

B) Artrite idiopática juvenil exige achados inflamatórios articulares persistentes, ausentes no enunciado.

C) Correta: epifisiólise do fêmur proximal deve ser investigada urgentemente, evitando apoio de peso.

D) Sinovite transitória é geralmente autolimitada, sem o perfil clássico de obesidade/rotação externa descrito.

Referências: [2]

Imagem 06 — Resposta: B

Na classificação de Winters–Gage–Hicks, o tipo III de hemiparesia espástica acomete tornozelo/pé e joelho.

A) Tipo I envolve principalmente queda do pé; é menos abrangente que o tipo III.

B) Correta: alterações do pé/tornozelo e comprometimento do joelho.

C) Corresponde melhor ao padrão tipo IV, com acometimento adicional do quadril.

D) Não descreve adequadamente o padrão distal de pé/tornozelo do tipo III.

Referências: [3]

Imagem 07 — Resposta: B (comparação simplificada)

Entre as opções, o traço espiral costuma propiciar maior superfície de contato que certos traços simples transversos; consolidação real depende de vascularização, estabilidade e lesão de partes moles.

A) Fraturas cominutivas têm mais fragmentos e podem perder estabilidade ou suprimento vascular, não sendo em regra as de consolidação mais simples.

B) Alternativa preferível no sentido clássico de ampla área de contato, mas não há garantia de consolidação mais rápida só pelo desenho do traço.

C) O desvio em valgo é desalinhamento, não atributo que favoreça consolidação.

D) O desvio em varo igualmente não favorece a estabilidade anatômica nem garante consolidação.

Referências: [5]

Imagem 07a — Resposta: D (com ressalva)

O anticoagulante lúpico pode integrar a investigação de síndrome antifosfolípide associada ao LES, mas positividade isolada não confirma a síndrome.

A) Anti-Sm é altamente específico do LES; positividade em AR típica é incomum e não representa associação clássica.

B) O anti-RNP associa-se a doença mista do tecido conjuntivo e LES; também pode aparecer em Sjögren, de modo que a exclusão absoluta não é válida.

C) Anti-Ro/La associam-se sobretudo a Sjögren e LES, mas podem ocorrer em sobreposições com esclerose sistêmica; redação não absolutamente falsa.

D) Mais adequada: anticorpo antifosfolípide positivo pode sugerir investigação de SAF secundária, dependente de critérios clínicos e confirmação persistente.

Referências: [4]

Imagem 08 — Resposta: D

Fator reumatoide pode ser detectado em Sjögren, hepatite C e artrite reumatoide; não é específico para AR.

A) Incorreta por incompleta: I e II podem ser positivas, mas III também.

B) Incorreta por incompleta: II e III podem ser positivas, mas I também.

C) Incorreta: a presença não se restringe à artrite reumatoide.

D) Correta: as três condições podem cursar com fator reumatoide positivo.

Referências: [13]

Imagem 09 — Resposta: C (histórica e dependente do cenário)

Acidentes de trânsito foram historicamente causa dominante de trauma medular em muitas séries; os percentuais variam com o país, época e envelhecimento populacional.

A) Ferimento por arma de fogo é relevante em certas regiões, mas não a principal causa universal.

B) A coluna lombar não é universalmente a região mais atingida; os segmentos cervicais são muito frequentes.

C) Melhor resposta no enquadramento epidemiológico clássico, porém o percentual acima de 50% não é universal nem permanente.

D) A região torácica não é consistentemente a localização mais comum em todas as populações.

Referências: [14]

Imagem 10 — Resposta: D

O rastreamento com densitometria é recomendado para mulheres a partir de 65 anos e para pacientes mais jovens com risco aumentado.

A) Somente a idade de 40 anos não indica DXA de rotina para homens.

B) Somente 40 anos não justifica exame universal em mulheres.

C) O primeiro ano após menopausa não constitui indicação universal, sem fatores adicionais.

D) Correta: mulheres com 65 anos ou mais devem ser rastreadas.

Referências: [6]

Imagem 11 — Resposta: D (ressalva ao termo “toda”)

A restauração da congruência articular é objetivo central no tratamento das fraturas intra-articulares, principalmente quando deslocadas.

A) Fraturas desviadas não consolidam invariavelmente mais rápido; o desvio pode dificultar união.

B) A consolidação clínica geralmente antecede a consolidação radiográfica completa.

C) Nem toda fratura desviada necessita cirurgia; depende de estabilidade, alinhamento e outras características.

D) Melhor alternativa em sentido didático: deve-se buscar redução anatômica nas fraturas articulares deslocadas; uma fratura sem desvio pode não exigir manobra de redução.

Referências: [5]

Imagem 12 — Resposta: B

Uso prolongado de heparina, sobretudo não fracionada, associa-se à redução de densidade óssea e fraturas.

A) Tiazídicos reduzem excreção urinária de cálcio e não são causa clássica de osteoporose.

B) Correta: heparina prolongada pode produzir perda óssea, com risco variável conforme formulação/duração.

C) Loratadina não é causa clássica de osteoporose.

D) Carvedilol não representa causa habitual de osteoporose medicamentosa.

Referências: [6]

Imagem 13 — Resposta: Sem resposta segura

A pergunta sobre a fratura diafisária do úmero foi cortada antes de informar o que se deseja identificar (direção, estrutura, acesso ou outra relação).

A) Não é possível definir o significado de “anterior” sem o trecho ausente.

B) Não é possível definir o significado de “medial” sem o trecho ausente.

C) Não é possível definir o significado de “lateral” sem o trecho ausente.

D) Não é possível definir o significado de “posterior” sem o trecho ausente.

Referências: [5]

Imagem 14 — Resposta: B (teste provocativo, não confirmatório isolado)

A manobra de Patrick/FABER pode provocar dor na região sacroilíaca, mas não confirma sacroileíte isoladamente.

A) Tinel avalia irritação de nervos periféricos.

B) Correta no contexto: Patrick-FABER mobiliza quadril e articulação sacroilíaca.

C) Phalen avalia compressão do nervo mediano no túnel do carpo.

D) Thompson avalia integridade do tendão calcâneo (Aquiles).

Referências: [13]

Imagem 15 — Resposta: C

A VHS depende em grande parte do fibrinogênio, que aumenta a agregação das hemácias; não mede diretamente sua concentração.

A) Haptoglobina é proteína de fase aguda, mas não é o principal determinante medido pela VHS.

B) Amiloide A é reagente de fase aguda, porém não explica o mecanismo predominante do teste.

C) Correta: fibrinogênio facilita formação de rouleaux e acelera a sedimentação.

D) Albumina não é marcador responsável pelo aumento típico da VHS e tende a diminuir na inflamação.

Referências: [13]

Imagem 16 — Resposta: C (ressalva epidemiológica)

Nefrite lúpica classe IV, difusa proliferativa, é uma apresentação importante e frequentemente relatada entre as formas biopsiadas; frequência depende da população.

A) Anticoagulante lúpico não é marcador usual ou obrigatório da atividade da nefrite lúpica.

B) O acometimento renal do LES é relativamente frequente, não raro.

C) Correta no entendimento clássico dos casos biopsiados: a classe IV é uma forma proliferativa comum e grave; não é predominante em todas as séries.

D) Proteinúria importante pode ser justamente indicação de biópsia, após avaliação de riscos; não é contraindicação por si só.

Referências: [7]

Imagem 17 — Resposta: A

Entesite, especialmente do calcâneo/Aquiles ou fáscia plantar, é manifestação característica das espondiloartrites.

A) Correta: entesopatia do calcâneo é manifestação frequente.

B) Poliartrite simétrica crônica das pequenas articulações não é o padrão mais comum da espondilite anquilosante.

C) O comprometimento ocular típico é uveíte anterior, não coriorretinite.

D) Na artrite psoriásica, a psoríase cutânea em geral precede a artropatia; exceções ocorrem.

Referências: [13]

Imagem 18 — Resposta: C

As espondiloartrites podem provocar uveíte anterior aguda unilateral e recorrente.

A) Subluxação atlantoaxial é mais clássica de artrite reumatoide que do grupo como um todo.

B) Anti-CCP é relacionado sobretudo à artrite reumatoide; HLA-B27 é importante em espondiloartrites axiais.

C) Correta: iridociclite (uveíte anterior) frequentemente é unilateral, aguda e recidivante.

D) A artrite periférica costuma predominar de forma assimétrica nos membros inferiores, não superiores.

Referências: [13]

Imagem 19 — Resposta: D (interpretação de “achatamento”)

Herring: A mantém altura do pilar lateral; B mantém mais de 50%; C mantém menos de 50%, ou seja, perdeu mais de 50% da altura.

A) Grupo A não apresenta achatamento de 50%; o pilar lateral preserva altura.

B) Se o pilar perdeu 70%, sobra 30%: corresponde a C, não B.

C) Se perdeu 60%, sobra 40%: também C, não B.

D) Correta se “achatamento acima de 50%” significa perda de mais de 50% da altura do pilar lateral.

Referências: [8]

Imagem 20 — Resposta: D (com ressalvas)

Corticoides tópicos e inalatórios, especialmente em doses altas, áreas extensas ou uso prolongado, podem ter absorção sistêmica e causar efeitos adversos semelhantes aos da via oral.

A) Nimesulida e meloxicam são preferencialmente COX-2 em graus distintos, não se resumem corretamente a “não seletivos” sem qualificação.

B) Mesmo coxibes seletivos podem afetar perfusão e função renal; deve haver avaliação clínica.

C) Baixas doses cumulativas/prolongadas de corticoides podem elevar risco de perda óssea; avaliação depende de dose, duração e outros fatores.

D) Correta em sentido de possibilidade, não de equivalência de risco: efeito sistêmico pode ocorrer com vias inaladas/tópicas.

Referências: [6]

Imagem 21 — Resposta: C

Fraturas expostas demandam avaliação e tratamento urgente, incluindo antibioticoprofilaxia apropriada, irrigação/desbridamento e estabilização.

A) Tamanho da ferida participa da classificação de Gustilo, mas energia, contaminação, partes moles e vascularização são essenciais.

B) Ferida rural/contaminada e possível lesão arterial não podem ser automaticamente grau II por medir 4 cm; lesão arterial que exige reparo implica grau IIIC.

C) Correta: infecção é complicação central; desbridamento e limpeza apropriados são medidas fundamentais.

D) Fratura exposta não é geralmente tratada apenas de modo conservador por ter mais de 6 horas; a demora não favorece isso.

Referências: [5], [9]

Imagem 22 — Resposta: Sem resposta única (A ou B podem ocorrer)

O quadro sugere LES, mas ele não determina o padrão de imunofluorescência do FAN; padrões nuclear homogêneo e pontilhado fino podem ocorrer.

A) Plausível: o padrão pontilhado fino está documentado no LES.

B) Também plausível: padrão nuclear homogêneo pode ocorrer com anticorpos anti-DNA/cromatina em LES.

C) Pontilhado fino denso isolado (frequentemente anti-DFS70) é menos sugestivo de doença autoimune sistêmica.

D) Centromérico é classicamente associado a esclerose sistêmica limitada e não ao quadro mais típico descrito.

Referências: [11]

Imagem 23 — Resposta: A

O quadro descreve gonartrose sintomática com dor mecânica; a bengala pode reduzir carga e melhorar segurança da marcha.

A) Correta: uso individualizado de bengala é recomendado quando OA compromete deambulação e estabilidade.

B) Artroplastia bilateral imediata não é primeira conduta universal; exige avaliação de gravidade e falha de tratamento não cirúrgico.

C) IMC 23 não é obesidade; controle ponderal pode ser útil se houver excesso de peso, não comprovado aqui.

D) Prednisona sistêmica prolongada não é tratamento habitual da OA mecânica e traz riscos.

Referências: [12]

Imagem 24 — Resposta: Sem resposta segura

Alternativas com trechos essenciais truncados; não é possível avaliar corretamente qual está certa sem o enunciado original completo.

A) A localização de fratura exposta mais comum depende da população; opção incompleta.

B) O conceito de comunicação da fratura com o exterior é pertinente, mas a frase foi cortada.

C) A indicação e o grau de Gustilo estão truncados e impedem julgamento.

D) O texto sobre desbridamento e segurança está truncado; não é possível confirmar.

Referências: [9]

Imagem 25 — Resposta: Sem resposta segura

Enunciado e alternativas contêm cortes extensos, impedindo até determinar o atributo clínico cuja frequência ou risco é questionado.

A) Não é possível conferir afirmação histórica interrompida.

B) Não é possível conferir afirmação epidemiológica truncada.

C) Fator descrito como “2IdC (?)” é ilegível e não deve ser inferido.

D) Tipo de fratura e proposição final não estão suficientemente disponíveis.

Referências: [5]

Imagem 26 — Resposta: C (mais provável)

No exame radiográfico inicial dos ossos da perna, são fundamentais incidências anteroposterior e perfil, incluindo articulações vizinhas quando adequado.

A) Quatro incidências incluindo oblíquas podem ser úteis em casos selecionados, mas não constituem a série inicial básica.

B) A vista axial do tornozelo não é exame inicial padrão de toda a perna.

C) Correta para avaliação inicial: AP e perfil.

D) A incidência axial da patela é voltada ao joelho/patelofemoral, não à avaliação geral dos ossos da perna.

Referências: [5]

Imagem 27 — Resposta: D

Treino resistido é importante para força, saúde óssea e prevenção de quedas; combinar com treino de equilíbrio e impacto conforme capacidade.

A) Hidroginástica melhora condicionamento e mobilidade, mas oferece menor estímulo de carga gravitacional óssea.

B) Natação é benéfica à saúde geral, com pouco estímulo osteogênico pela flutuação.

C) Alongamentos melhoram flexibilidade, não são o principal estímulo para ganho de massa óssea.

D) Correta: musculação com sobrecarga progressiva é a melhor opção apresentada.

Referências: [6]

Imagem 28 — Resposta: A

Proeminências ósseas sob pressão, especialmente sacro, ísquios, trocânteres e calcâneos, concentram lesões por pressão conforme posição corporal.

A) Correta: regiões sacra, isquiática e trocantérica são locais clássicos de alto risco.

B) Calcâneo e trocânter são importantes, mas joelhos não são tão classicamente prevalentes nessa combinação.

C) Inclui trocânter e calcâneo, porém nuca é menos típica do que sacro e ísquio na maioria dos pacientes.

D) Essas áreas podem lesionar em posições específicas, mas não representam o conjunto predominante.

Referências: [15]

Imagem 29 — Resposta: C (provisória; enunciado incompleto)

Fixação de fraturas diafisárias da tíbia pode incluir placas/parafusos em situações selecionadas, embora haste intramedular seja comum.

A) Fraturas diafisárias da tíbia não são tipicamente mais frequentes em mulheres em todas as séries.

B) O tratamento conservador é possível em casos estáveis selecionados; a justificativa do item está incompleta.

C) Fato defensável: placas e parafusos são uma opção cirúrgica, mas o restante da alternativa também foi parcialmente cortado.

D) Não é possível julgar completamente a relação com lesões ligamentares do joelho, pois a frase foi truncada.

Referências: [5]

Imagem 30 — Resposta: B

Paralisia cerebral resulta de lesão ou alteração não progressiva no encéfalo imaturo, embora manifestações funcionais mudem com o crescimento.

A) A encefalopatia causal não é progressiva por definição e não decorre obrigatoriamente dos núcleos da base.

B) Correta: condição de origem não progressiva do cérebro em desenvolvimento.

C) Não é doença neurodegenerativa lentamente progressiva.

D) Déficit cognitivo não é universal nem possui prevalência fixa de 85%; pode haver inteligência preservada.

Referências: [3]

Imagem 31 — Resposta: D

A fratura do colo do fêmur pode causar necrose avascular e não união; mesmo fraturas Garden I/II geralmente exigem avaliação cirúrgica.

A) Correta como tendência, com exceções: fixação em jovens; artroplastia mais comum em idosos com fraturas desviadas.

B) Correta: a vascularização da cabeça é mais ameaçada nas fraturas intracapsulares.

C) Correta no esquema tradicional: Garden I e II são impactadas/não desviadas; III e IV apresentam desvio.

D) Incorreta como regra geral: fraturas não desviadas não são automaticamente conservadoras; fixação é frequente conforme risco.

Referências: [16]

Imagem 32 — Resposta: A

Compressão do nervo mediano no túnel do carpo causa parestesia no polegar, indicador, médio e metade radial do anelar.

A) Correta: corresponde ao território sensitivo clássico do nervo mediano.

B) Não descreve precisamente a participação do polegar e metade radial do anelar.

C) A maior parte do quinto dedo e metade ulnar do anelar pertencem ao nervo ulnar; o polegar participa.

D) O quinto dedo geralmente não participa da distribuição típica mediana.

Referências: [13]

Imagem 33 · questão 1 — Resposta: C

A menor eliminação renal de urato é o mecanismo predominante na hiperuricemia da gota primária. Questão repetida no documento original, mantida integralmente.

A) A dieta pode contribuir, mas não é o principal mecanismo isolado.

B) O aumento de renovação celular explica causas de hiperprodução, como algumas neoplasias; não é a explicação predominante da gota primária.

C) Correta: a subexcreção renal de urato predomina, com fatores genéticos e renais.

D) A deficiência completa de HGPRT causa síndrome de Lesch-Nyhan, forma rara de hiperprodução; não corresponde à maioria dos casos.

Referências: [1]

Imagem 33 · questão 2 — Resposta: A

Compressão do nervo mediano no túnel do carpo causa parestesia no polegar, indicador, médio e metade radial do anelar. Questão repetida no documento original, mantida integralmente.

A) Correta: corresponde ao território sensitivo clássico do nervo mediano.

B) Não descreve precisamente a participação do polegar e metade radial do anelar.

C) A maior parte do quinto dedo e metade ulnar do anelar pertencem ao nervo ulnar; o polegar participa.

D) O quinto dedo geralmente não participa da distribuição típica mediana.

Referências: [13]

Imagem 33 · questão 3 — Resposta: Sem resposta única (A ou B podem ocorrer)

O quadro sugere LES, mas ele não determina o padrão de imunofluorescência do FAN; padrões nuclear homogêneo e pontilhado fino podem ocorrer. Questão repetida no documento original, mantida integralmente.

A) Plausível: o padrão pontilhado fino está documentado no LES.

B) Também plausível: padrão nuclear homogêneo pode ocorrer com anticorpos anti-DNA/cromatina em LES.

C) Pontilhado fino denso isolado (frequentemente anti-DFS70) é menos sugestivo de doença autoimune sistêmica.

D) Centromérico é classicamente associado a esclerose sistêmica limitada e não ao quadro mais típico descrito.

Referências: [11]

Imagem 33 · questão 4 — Resposta: Sem resposta segura

O documento termina no início da questão 4 sobre anti-inflamatórios, sem as respectivas alternativas.

A) Alternativa A não consta no documento.

B) Alternativa B não consta no documento.

C) Alternativa C não consta no documento.

D) Alternativa D não consta no documento.

Referências: [13]

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fontes clínicas e diretrizes consultadas. Os números remetem aos comentários das questões.

[1] ACR. 2020 Guideline for Management of Gout
https://acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/art.41247

[2] AAOS OrthoInfo. Slipped Capital Femoral Epiphysis
https://www.orthoinfo.org/diseases--conditions/slipped-capital-femoral-epiphysis-scfe

[3] Clinical Examination of Children with Cerebral Palsy (2019)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6394192/

[4] ACR/EULAR. Antiphospholipid Syndrome Classification Criteria (2023)
https://ard.bmj.com/content/82/10/1258

[5] NICE. Hip fracture: management (CG124)
https://www.nice.org.uk/guidance/cg124/chapter/Recommendations

[6] USPSTF. Osteoporosis Screening (2025)
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/osteoporosis-screening

[7] KDIGO. Lupus Nephritis Guideline (2024)
https://kdigo.org/guidelines/lupus-nephritis/

[8] Herring classification — Classifications in Brief
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3676599/

[9] Gustilo–Anderson Classification of Open Fractures
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3462875/

[10] MSD Manual. Elbow Dislocations: Treatment
https://www.msdmanuals.com/professional/injuries-poisoning/dislocations/elbow-dislocations

[11] Clinical study: ANA patterns and DFS70 in SLE
https://lupus.bmj.com/content/4/Suppl_1/A113.1

[12] ACR/Arthritis Foundation. Osteoarthritis Management (2019)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10518852/

[13] Merck/MSD Manual — Professional medical reference
https://www.msdmanuals.com/professional

[14] National Spinal Cord Injury Statistical Center — Facts and Figures
https://www.nscisc.uab.edu/public_pages/FactsFiguresHome.aspx

[15] NPIAP — Pressure Injury Prevention and Staging
https://npiap.com/

[16] NICE Hip fracture: nondisplaced intracapsular evidence
https://www.nice.org.uk/guidance/cg124/evidence